

□Examen fédéral en médecine 2019□

Pour faciliter le travail d'équipe, nous avons numéroté les questions, les rares K' sont indiquées par un K après le numéro. A l'examen seules quelques questions type A n'avaient que 4 propositions, ici vous en trouverez davantage car oublié.

Bon courage à toutes et à tous !

Premier round, 8K'

1. Patiente de 40 ans sans antécédent notable, qui consulte son médecin traitant pour un contrôle de routine. L'examen clinique sans particularité à l'exception de la palpation d'un nodule thyroïdien. La patiente ne se plaint ni de douleurs, ni de dysphagie, ni de sensation de chaud-froid ou d'autres symptômes thyroïdiens. Au laboratoire, la TSH est dans les normes. Quel est le prochain examen recommandé:

- ☒ A. échographie
- ☐ B. IRM
- ☐ C. Scintigraphie
- ☐ D. biopsie à ciel ouvert



2. Que voyez-vous sur le CT de ce patient atteint d'un déficit en alpha-1-antitrypsine?

- ☒ A. Bronchiectasie
- ☐ B. Épanchement pleural
- ☐ C. Tuberculose
- ☐ D. Aspergillose

3. Patiente de 50 ans, qui vous consulte en raison d'un scotome central de l'œil droit. Diagnostic de décollement de la rétine. Au fond œil, vous observez une masse brunâtre. A quoi devez vous penser en 1er lieu ?

- ☐ A. Hémorragie sous rétinienne
- ☒ B. Mélanome de la choroïde
- ☐ C. Métastase d'un cancer du sein

4. Une maman vous consulte avec son garçon de 2.5 ans. Elle est inquiète car elle trouve qu'il est en retard par rapport à son cousin. Il n'est pas encore propre.

Elle a une liste résumant son développement:

- Sourit à 6 semaines
- Fixe à 2 mois
- Tient assis à 7 mois
- Pince à 9 mois
- Tient debout avec appui à 11 mois
- Premiers mots à 12 mois
- Premiers pas à 13 mois
- Shooté dans un ballon à 24 mois

Que dites-vous à cette maman?

- A. Le développement de son enfant est normal
- B. Son enfance présente un retard sur le plan moteur
- C. Son enfant présente un retard sur le plan cognitif
- D. Son enfant présente un retard sur le plan langagier
- E. Son enfant présente un retard sur plusieurs domaines

5. Un homme de 30 ans est amené par la police en ambulance, on apprend qu'il a fait une crise tonico-clonique dans l'ambulance. A son arrivée le patient est inconscient. Deux heures plus tard il demeure toujours inconscient, mais ne montre aucune convulsion. Status neurologique dans la norme. Labo dans la norme. Légère atrophie cérébrale au CT. Vous apprenez par la famille qu'il n'avait pas de problème de santé hormis une consommation excessive d'alcool. Que faites-vous:

- A. EEG en urgence
- B. Phénytoïne i.v.
- C. IRM en urgence
- D. Contrôle neurologique aux 2h et observation
- E. Consilium neurologique à organiser le lendemain

6. Femme de 35 ans, enceinte, qui consulte son médecin traitant pour des douleurs abdominales sous forme de crampes. A l'examen clinique on retrouve une sensibilité de l'hypochondre droit sans péritonisme. Au laboratoire, on distingue une leucocytose et une CRP augmentée. Quel examen permet de poser le diagnostic ?

- A. Radiographie abdominale en décubitus latéral gauche
- B. Scanner abdominal
- C. US abdominal
- D. Laparoscopie exploratrice
- E. IRM abdominale

7. Enfant de 14 ans, vient pour des douleurs abdominales intermittentes depuis 1 an. Douleurs diffuses, avec épisodes de diarrhée, sans saignement. Quelques états fébriles par-ci par-là (Max 38°C je crois). Pas d'autre signe, rien de flagrant à l'examen clinique, abdomen souple, à part 2 lésions aphtes buccales.

Quel est le diagnostic le plus probable:

- A. maladie de Crohn
- B. Colite ulcéreuse
- C. Oxyure
- D. Abdomen fonctionnel
- E. Giarda (y'a pas moyen Giarda)

8. Un nouveau-né présente, dès les premières heures de vie, une hypersialorrhée ainsi qu'une mousse blanche au niveau des lèvres. Par moments, il se met à tousser, devient cyanosé et se rétablit très rapidement. La fréquence respiratoire est de 40 par minute. À l'auscultation des poumons et de la trachée, on entend des râles bulleux.

Quelle est le diagnostic le plus probable:

- A. Oedème pulmonaire aigu

- B. Mucoviscidose
- C. Cardiopathie congénitale
- D. Atrésie de l'oesophage**
- E. Aspiration massive du liquide amniotique

9. Lors d'une étude, des anesthésistes cherchent à démontrer que l'administration d'une dose de dexaméthasone préopératoire diminue les vomissements post-opératoire dus à l'anesthésie. Ils effectuent une **étude randomisée** avec 1200 patients. 600 patients reçoivent une dose de dexaméthasone pré-opératoire, et 138 présentent des vomissements postopératoires (23%). 600 ne reçoivent pas de dexaméthasone, et 198 d'entre-eux présentent des vomissements post-opératoires (33%). Cette association est statistiquement significative (p value < 0.05).

Laquelle des propositions suivante est VRAI :

- A. L'odds ratio vaut 0.7 $OR = \frac{P/(1-P)}{q/(1-q)} = \frac{0,23/0,77}{0,33/0,67} = 0,6$
- B. Le risque relatif de vomissement avec la dexaméthasone est de 1.4 $RR = \frac{23}{33} = 0,7$
- C. La réduction de risque de vomissement avec la dexaméthasone est de 10% $\frac{33-23}{33} = 30\%$
- D. Le nombre de patient à traiter pour éviter un épisode de vomissement (NNT) est de 10** $NNT = \frac{1}{RRA} = \frac{1}{0,1} = 10$
- E. Le risque absolue de vomissement est réduit de 40% $RRA = 33-23 = 10\%$

10. En tant que médecin de garde vous êtes appelé au chevet d'un enfant de 4 ans en bonne santé habituelle. Il est inconscient, après avoir dormi chez ses grands-parents dans une chambre à proximité du chauffage au bonbonnes de butane. Les grands parents dorment dans une chambre séparée, la fenêtre toujours grande ouverte. La status cardiopulmonaire, tout comme les muqueuses est normal. Les grands parents mentionnent avoir mangé la veille des fruits de mer, et avoir de légères nausées.

Quelle est la cause la plus probable?

- A. Intoxication au monoxyde de carbone
- B. Allergie alimentaire
- C. Intoxication alimentaire
- D. Bronchopneumonie
- E. Brûlures chimiques

11. Patient de 86 ans ex-tabagique 56 UPA, HTA, ATCD infarctus du myocarde il y a 5 ans. Hospitalisé pour une dyspnée aiguë. Présente depuis longtemps une toux matinale avec expectorations jaunâtres, mais autrement asymptomatique. Il y a une semaine a présenté un état grippal et toux. Constantes : FR 24/min, FC 72/min, TA 145/92.

Status : auscultation cardiaque dans la norme, ausc pulmonaire avec murmure vésiculaire très diminué ddc mais sans bruits discontinus surajoutés.

Labo : leucos X, Hb normale, BNP 145 (norme < 100), D-dimères 0.6 (norme 0.5), CRP 95mg/dl (N < 10)

Gazo : PaO2 50 mmHg, PaCO2 60 mmHg.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Embolie pulmonaire
- B. Décompensation BPCO
- C. Insuffisance cardiaque aiguë
- D. Inhalation de corps étranger

12. Patiente 78 ans, robuste, en BSH. Depuis 2 jours se plaint de douleurs dorsales aiguës qui dépendent des mouvements. La douleur augmente à la marche et lorsqu'elle se penche en avant. Il n'y a pas eu de trauma.

À l'examen clinique : douleur à la percussion et palpation du corps T8. Pas de douleur à la compression du rachis.

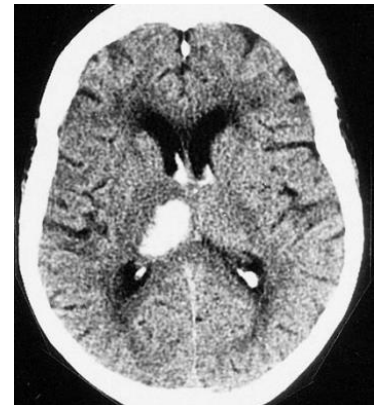
- A. Hernie discale aiguë
- B. Fracture du corps vertébral.
- C. Canal étroit
- D. Cauda equina
- E. Ostéoporose

13. Une petite fille de 18 mois amenée par sa maman à 22h aux urgences, car depuis qu'elle s'est réveillée elle présente une toux aboyante et une dyspnée. Elle n'a jamais eu de maladie grave et ses vaccinations sont à jour. Elle présente un stridor inspiratoire net, un bon état général, et une toux aboyante.

- A. antibiothérapie
- B. Cortisone par voie générale
- C. Bêta mimétique inhalé
- D. Intubation et ventilation
- E. Paracétamol

14. Patient de 76, sans antécédents cardiovasculaires qui présente un hémisyndrome gauche. CT sans contraste donné (ci-contre). Quel est le diagnostic le plus probable?

- A. Rupture d'anévrisme
- B. Hémorragie hypertensive
- C. Rupture de malformation artérioveineuse
- D. Vasculite
- E. Thrombose veineuse



15. Patiente de 80 ans hypertendu qui prend du valsartan. Elle vient aux urgences car elle a des diarrhées et des vomissements à chaque fois qu'elle s'alimente ainsi qu'une fièvre de 38,5 depuis 48 heures. Sa tension est à 90/70, elle est tachycarde et elle est déshydratée. Au Labo on retrouve une créatinine élevée. Que retrouve-t-on dans les urines?

- A. Na⁺ 10 mmol/l, K⁺ 4 mmol/l et osmolarité urinaire normale
- B. Na⁺ 8 mmol/L, K⁺ 22 mmol/l et osmolarité urinaire élevée
- C. Na⁺ 22 mmol/l, K⁺ 60 mmol/l et osmolalité urinaire normale
- D. Na⁺ 24 mmol/l, K⁺ 66 mmol/l et osmolalité urinaire élevée
- E. Na 60 mmol/l, K 4 mmol/l et osmolalité urinaire normale

IRA pré-rénale
urine: Na⁺ < 20 mmol/L
FENa < 1%
Osmolalité ↑ (> 500 mOsm/kg)

16. Une patiente de 47 ans en bsh consulte en raison d'une masse palpée dans son sein droit. Elle ne présente pas de symptômes. Quelle prise en charge est appropriée ?

- A. IRM et biopsie
- B. Mammographie et échographie
- C. CT thoraco-abdominal
- D. PET CT

17. Une patiente de 48 ans connue pour une polykystose rénale fait appel à son généraliste pour une plainte de céphalées sévères d'apparition brusque depuis une heure. Elle ne se rappelle pas avoir eu des céphalées aussi intenses auparavant. Quelle est la cause la plus probable ?

- A. Rupture d'anévrisme
- B. Maladie de Horton
- C. Migraine
- D. AVC ischémique
- E. Glaucome à angle fermé

18. Femme de 80 ans, aux urgences, douleur abdo diffuse importante, en augmentation, avec détente à la palpation. A eu des douleurs abdo la veille très importante après le repas. TA 90/50. Fièvre. Crp 300, leuco 30, lactate 8. Antécédents de fibrillations auriculaire et maladie coronarienne. Quel examen pour le diagnostic?

- A. us abdo
- B. Ct non injecté
- C. Ct injecté
- D. ASP 2 incidences
- E. angioscanner

19. Un homme de 41 ans consulte en polyclinique pour un écoulement urétral purulent et une dysurie légère. Il a l'air stressé et distrait. Quand on lui pose la question, il dit avoir eu des rapports sexuels non-protégés. Le reste de l'anamnèse et de l'examen clinique est sans particularité. Des analyses urinaires (sédiment) reviennent dans les normes. On prélève des urines et on effectue un frottis urétral pour la microbiologie (pour des cultures). Que faut-il absolument faire avant de laisser le patient rentrer à domicile ?

- A. Attendre les résultats de la culture avant de traiter
- B. Prescrire un traitement de ceftriaxone et azithromycine
- C. Prescrire un traitement symptomatique avec AINS
- D. Prescrire un traitement de triméthoprim-sulfaméthoxazole
- E. Donner un traitement de fosfomycine

20. Un homme de 33 ans se présente aux urgences en raison d'un oedème douloureux de la face, touchant également les lèvres et la langue, apparu il y a 4 heures et croissant rapidement. Il a subi il y a 2 ans une greffe rénale et est actuellement sous traitement de ciclosporine, mycophénolate et prednisone. Il n'a pas d'allergie connue. La laboratoire d'entrée montre des leucocytes à 14.07, des neutrophiles à 13.84 et une CRP à 81. Le patient se présente ainsi :

(photo du visage d'un gaillard barbu avec langue proéminente et lèvres gonflées. Le piètre clinicien que je suis n'a rien relevé d'autre de particulier. Je rajoute qu'il avait soit un double menton soit un oedème du cou)

Quel est le traitement à instaurer d'urgence :

- A. Hémoculture et début d'une antibiothérapie à large spectre.
- B. Antihistaminiques et corticoïdes intraveineux.
- C. Plasma frais congelé et acide tranexamique intraveineux.
- D. Hospitalisation et observation de surveillance.

E. Inhibiteur de C1 estérase intraveineux.

21. Une coiffeuse de 31 ans présente des myalgies avec sudation, fatigue. Elle a mal à la mâchoire depuis qu'elle a été chez le dentiste il y a 10 jours. Au status, on retrouve à l'auscultation cardiaque, un souffle éjectionnel à 3/6 et le reste du status est sp. Elle est hypotendue à 90/60 mmHg, tachycarde à 120 bts/min, fébrile à 39°C et saturation en oxygène à 98%. Au labo: leucocytose à 14G/l avec CRP élevée et coques gram + en chaînette au frottis. De plus protéines ++ à la BU. Quel examen faut-il faire:

- A. US rein
- B. US cœur
- C. CT thoraco-abdo
- D. orthopantomographie
- E. Ponction lombaire

22. Un patient de 62 ans, connu pour une BPCO et un carcinome pulmonaire à petites cellules traité par chimiothérapie palliative, se présente pour un état fébrile une semaine après sa dernière cure. Il présente une dyspnée associée. Au status, on retrouve un état fébrile à 39°C, une fréquence cardiaque à 115/min et une tension artérielle à 90/70, également une fréquence respiratoire à 22/min. Le laboratoire montre des leucocytes à 1.1G/l, dont 0.15 neutrophiles, une CRP à 90 mg/l. Des hémocultures sont en cours.

Quelle est la prise en charge la plus appropriée?

- A. Fébrifuges et contrôle ambulatoire à 24h
- B. Fébrifuges et hospitalisation pour surveillance
- C. Amoxicilline-clavulanate p.o. et contrôle ambulatoire
- D. Amoxicilline-clavulanate en i.v. et hospitalisation pour surveillance
- E. Céfépime en i.v. et hospitalisation pour surveillance

23. K'. Quelles sont les FDR pour une mort subite du nourrisson

- ☐ Température de la chambre > 21°C
- ☐ Partage du lit parental
- ☐ Dormir avec une sucette (pas si qu'ils disaient dormir avec...)
- ☐ Dormir sur le dos(ventre ?)

24. Patiente de 27 ans se consulte à cause de douleurs initialement périombilicales, qui descendent ensuite dans la fosse iliaque droite. L'examen gynécologique montre un col avec des sécrétions blanchâtres, le col et l'utérus sont douloureux à la mobilisation. Paramètres vitaux sont dans la norme, à l'exception d'une légère tachycardie. Le test de grossesse urinaire est négatif.

Quel est le prochain examen complémentaire ?

- A. Doser b-hCG plasmatique
- B. US transvaginal**
- C. Laparoscopie exploratrice
- D. Antibiothérapie

25. K'. Patiente de 33 ans, connue pour une leucémie myéloïde aiguë, qui consulte aux urgences pour une dyspnée. Devant la péjoration de ses symptômes, elle doit être entubée



(si, si, c'était écrit comme ça dans l'examen!). La radio du thorax montre un truc du style (approximativement). Le diagnostic différentiel inclut :

- A. Oedème sur insuffisance rénale aiguë
- B. SDRA débutant
- C. pneumonie bilatérale
- D. oedème sur insuffisance cardiaque

26. Prématuré de 28SA. Les parents sont inquiets car ils ont un enfant qui est décédé d'une mort subite du nourrisson. Qu'est-ce qu'on doit leur dire?

- A. Vous les rassurez car la prématurité n'augmente pas le risque de mort subite du nourrisson
- B. Vous leur dites que faire dormir le bébé sur le ventre prévient la mort subite
- C. Vous les rassurez car il n'y a pas de risque plus élevé si fratrie a eu une mort subite
- D. Vous les informez que d'éviter le tabagisme dans l'entourage ainsi que l'allaitement prévient la mort subite
- E. On peut faire un EEG afin de prévoir si le bébé a des risques de faire une mort subite

27. Enfant de 7 ans amené par sa mère en raison de lésions cutanées présentes depuis un certain temps, très prurigineuses et le réveillant la nuit. Principalement aux coudes et aux genoux. A l'examen clinique: lésions érythémateuses avec desquamation dans les plis des coudes et genoux. Quel examen complémentaire est suffisant pour poser le diagnostic?

- A. Tests épicutanés
- B. Dermatoscope
- C. Biopsie cutanée
- D. Mesure IgE
- E. Examen clinique

28. Femme de 34 ans chez qui on a excisé un mélanome malin de type nodulaire de 2.3mm selon Breslow. On doit la ré-opérer avec nouvelle marge d'excision. Quelle est la méthode la plus adaptée pour détecter une potentielle métastase locorégionale ganglionnaires de très petite taille ?

- A. Tomodensitométrie par émission de positron
- B. IRM du creux axillaire
- C. Scintigraphie du ganglion sentinelle
- D. Excision des ganglion lymphatique du creux axillaire

E. CT du creux axillaire

29. Un patient bénéficie d'une réhabilitation des suites d'une hospitalisation pour une décompensation de BPCO. On peut s'attendre à une amélioration de quelle paramètre suite à cette réhabilitation:

- A. augmenter le VEMS du patient
- B. Diminuer la fréquence cardiaque du patient au repos
- C. augmenter sa capacité vitale
- D. Améliorer sa tolérance à l'effort
- E. ...

30. Un homme de 39 ans se présente à votre consultation pour un check-up. Il n'a pas vu de médecin depuis 10 ans. Il est tabagique à 20 UPA, sinon en BSH. Il est prof de Tango, célibataire et sans enfants. Il a été adopté dans l'enfance et ne connaît rien du passé médical de ses parents biologiques. Il n'a pas de plaintes et l'examen physique est dans la norme, avec TA 122/78, Puls 85/min. Quel est l'examen complémentaire le plus judicieux dans ce cas :

- A. Cholestérol et triglycérides à jeûn,
- B. HbA1c
- C. Labo sanguin avec FSC et tests hépatiques
- D. Radio du thorax
- E. Dépistage HIV

31. Une jeune demoiselle de 90 ans chute sur le bras. L'humérus gauche est fracturé. Elle n'arrive plus à faire une extension active du poignet ni des doigts. Quelle structure est lésée ?

- A. Nerf musculo-cutané
- B. Nerf axillaire
- C. Nerf radial
- D. Nerf médian
- E. Nerf ulnaire

32. Un bébé de qlq mois somnolent arrive aux urgences avec maman. Au CT des hémorragies sous dural bitemporo-pariétal sont observées. Le fond d'oeil montre des hémorragies rétinienues. La maman raconte qu'il est tombé d'une hauteur de 50cm pendant qu'elle lui donnait le biberon. Quelle est votre suspicion diagnostic ?

- A. bébé secoué
- B. trauma crânien
- C. Trouble de la crase
- D. Tumeur cérébrale
- E. syndrome de Crouzon

33. Un jeune de 25 ans présente depuis la veille des céphalées en progression avec un état fébrile à 39°. A l'admission il présente en plus une baisse de l'état de conscience associé à une hémiparésie, raideur de nuque. 93/65 TA 107/min. Sat à 95%.Pas de purpura. Pour résumer il présente une **méningite** sévère.

Prise en charge dans l'ordre:

- A. **Hémoculture- antibio- CT- PL**

- B. Antibio- hémoculture-CT- PL
- C. PL- Antibio- CT- hémoculture
- D. CT-PL-antibio

34. Un homme de 70 ans (environ) a perdu oeil (oui il manquait réellement des mots au fédéral) durant son enfance pour une raison inconnue. Il se plaint de voir moins bien depuis ces derniers temps, il voit des lettres déformées quand il lit le journal

- A. Cataracte
- B. dégénérescence maculaire
- C. Décollement rétinien
- D. Glaucome

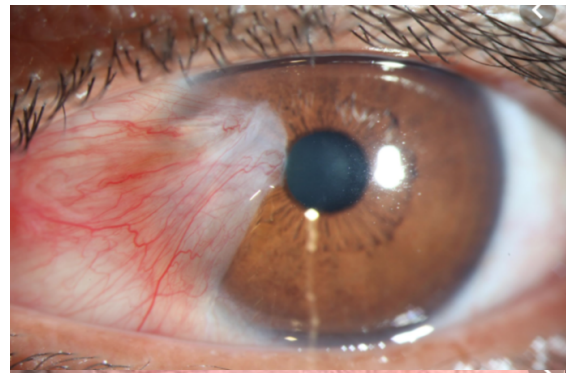
35. Une dame de 70 ans qui se fracture et se luxé l'humérus. Que faire?

- A. ostéosynthèse et réduction
- B. réduction fermée et plâtre

36. Un surfeur de 55 ans se présente à la consultation pour une baisse de la vision d'apparition graduelle. Vous observez ceci. Nommer la lésion oculaire

- A. Ptérygion
- B. Pinguécula
- C. Cataracte
- D. Kératite

Réponse: A



37. Une dame âgée arrive avec cette lésion. Qu'est ce que c'est:

- A. Dacryocystite
- B. Kérato-acanthome
- C. Abscess post-septale
- D. Basaliome
- E. Dacryoadénite

Réponse A



38. Un vieil homme connu pour une insuffisance cardiaque est hospitalisé pour une pneumonie. Il reçoit de l'augmentin, ça va beaucoup mieux au niveau de la dyspnée. Après 3 jours, la dyspnée revient. On observe un épanchement pleural à l'US et on ponctionne. De quelle origine est l'épanchement (dont voici quelques caractéristiques - incomplet)?

pH=6.8, LDH > 200, riche en protéine, cellularité> 20 000

- A. exsudat en lien avec la pneumonie
- B. transsudat en lien avec la pneumonie
- C. exsudat due à d'origine cardiaque
- D. transsudat sur AdCa pulmonaire
- E. exsudat d'origine tumorale



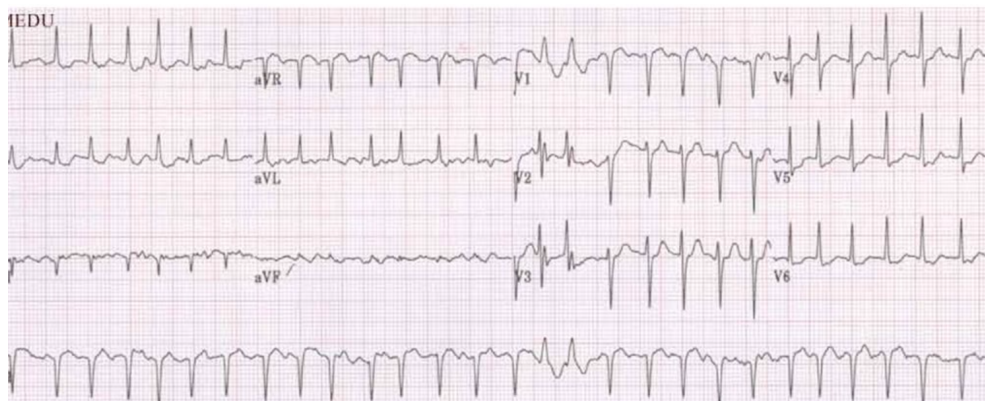


39. K'. Qu'est ce qui peut faire ce que vous voyez sur l'image (une macroscopie d'un foie coupé en tranche et une histologie du foie, j'ai essayé de trouver qlq chose de ressemblant). Quelle condition est compatible avec ce cliché ?

- A. NASH
- B. Hépatite A dans l'enfance
- C. Consommation abusive de diclofénac
- D. Déficit alpha-1-antitrypsine

40 Un patient de 76 ans présente des oedèmes des membres inférieurs ainsi qu'une dyspnée NYHA4 en péjoration depuis 7 jours. Au status on trouve des râles crépitants bibasaux.³ La TA est de 90/55 mmHg, Saturation 92%.

Voici son ECG, quel est la prise en charge appropriée?



- A. Adénosine IV en bolus
- B. Amiodarone IV
- C. Cardioversion électrique
- D. Digoxine

41. Un enfant de 8 ans reçoit un ballon de foot sur le thorax à la récré, il tombe et perd connaissance (il est fragile: à mon époque tu serais les dents et tu finissais le match). Une réanimation cardio pulmonaire est initiée mais le patient décède, qu'est-il arrivé?

- A. Torsade de pointe
- B. Fibrillation Ventriculaire
- C. Pneumothorax sous tension
- D. Tamponade péricardique

42. Une femme de 47 ans, mère de famille avec un BMI à 36 se présente aux urgences pour des douleurs épigastriques importantes en augmentation accompagnées de nausées et vomissements. Au status, elle présente on trouve une sensibilité en hypochondre droit sans

péritonisme. Les tests hépatiques sont modérément perturbés (ASAT, ALAT et Bilirubine). Au vu de l'obésité, un US abdominal est non contributif, on effectue donc une IRM abdominale. (Je trouve pas d'image utilisable: en gros un cholangiogramme moche où on pouvait rien distinguer..., la vésicule est non visible mais on voit une lacune de signal au niveau de l'ampoule de Vater et une dilatation des voies biliaires en amont).

Quel est la suite de la prise en charge?

- A. ERCP
- B. mesure des anticorps anti-transglutaminase et anticorps anti-endomysium
- C. Bilan cardiaque
- D. Recherche de parasites dans les selles
- E. Je donne ma langue au chat

43. Suspicion de rougeole chez un patient adulte. Vous demandez la recherche des sérologies IgM pour la rougeole à un laboratoire. Qui doit déclarer au médecin cantonal?

- A. ne doit pas être déclaré
- B. le médecin doit déclarer la suspicion dans les 2h
- C. le médecin doit déclarer la suspicion dans les 24h
- D. le médecin doit déclarer les résultats si la sérologie est positive
- E. le laboratoire doit déclarer les résultats si la sérologie est positive

Réponse: C

44. Homme 46 ans avec LDL augmenté à 4.6mmol/L, hypertendu à 146/90, fume ½ paquet depuis l'âge de 16 ans, qui fait du foot 1x par semaine ou toute les deux semaines. Sur quoi agir pour avoir le plus grand impact cardiovasculaire?

- A. arrêt du tabac
- B. manger moins de sel
- C. donner une antihypertenseur
- D. Activité physique hebdomadaire
- E. Introduction d'une statine

45. Une femme récemment hospitalisée se rend chez son généraliste en raison de crampes musculaire, faiblesse musculaire, fatigue et prise de poids. Elle est sous Simvastatine, Aspirine, Amiodarone (en raison d'une FA paroxystique), un IEC et un spironolactone.

Labo : CK 1290 ; K⁺ 6 ; TSH=30 ; Na=137

Quel traitement est responsable des symptômes ?

- A. Amiodarone
- B. IEC
- C. Aspirine
- D. Spironolactone
- E. Simvastatine

46. Un vieux monsieur va chez le toubib. ADP généralisées, splénomégalie.

Labo : Hb=136 ; Créat=95

Electrophorèse des protéines : grand pic gamma -> IgM kappa=30.2

- A. MGUS
- B. Leucémie lymphoplasmocytaire (Waldenström)
- C. Leucémie aiguë
- D. La grippe

47. Un gars va chez le médecin parce qu'il est gêné par sa hernie ombilicale. Il a eu une hépatite C non traitée, il a bien picolé dans sa vie. Au status on observe une hernie ombilicale sensible réductible. Vous remarquez qu'il y a aussi de l'ascite dans l'abdomen. Le patient veut absolument qu'on l'opère de sa hernie.

Labo : bili 30, Quick 30%, Albumine=15, plaquettes 80.

Prise en charge :

- A. Opération en urgence vu le risque de complication
- B. Vous programmez une opération élective
- C. Le score Child détermine le risque opératoire
- D. L'opération n'a aucune influence sur l'état de son foie

48. Un homme de 39 ans se plaint de vertiges à l'effort depuis quelques temps, TA et FC sp. Son frère est mort subitement il y a 2 jours. A l'auscultation cardiaque vous entendez un souffle proto-méso-systolique au milieu du coeur en crescendo puis decrescendo. Lorsque le patient se penche en avant vous n'entendez pas de souffle diastolique mais un souffle systolique net. Diagnostic

- A. Bicuspidie aortique
- B. Sténose pulmonaire
- C. Cardiomyopathie hypertrophique obstructive
- D. Prolapsus mitral
- E. Coarctation de l'aorte

49. On retrouve chez un patient une sérologie positive pour la syphilis à l'occasion d'un don du sang. Il signale avoir eu un ulcère indolore sur son petit paquet (scrotum) il y a 6 mois, ça a guéri tout seul. Actuellement pas de plainte. On lui file sa petite dose de pénic G im. Après 6 mois, le patient a toujours aucune plainte et on décide de lui refaire une sérologie pour le fun.

1er labo : VDRL=1/16 (norme 1/1) ; TPHA 1/40'000 (norme 1/1) ; test chelou IgM positif

2ème labo : VDRL=1/32 ; TPHA=1/20'000 ; test chelou IgM positif

Attitude :

- A. Pénic G im
- B. Pénic V iv
- C. Contrôle dans 1 an
- D. PL
- E. Sérologies Borrelia



50. Une patiente de 66 ans, obèse, se plaint depuis 1-2 ans d'une sensation progressive de réplétion avec des palpitations après les repas. Elle présente en outre une légère diminution de sa tolérance à l'effort. Elle est connue pour une hernie hiatale de longue date. Son MT vous la réfère avec ces rx de

thorax (on n'avait pas les flèches à l'exa):

Quel est le ttt indiqué chez cette patiente ?

- A. Opération
- B. Ponction
- C. Antibiotiques
- D. Bêta bloquants
- E. Anticoagulation

51. Garçon de 6 ans en bonne santé habituelle et sans antécédent particulier est amené aux urgences parce qu'il a la sensation d'avoir le cœur qui « tape trop fort ». Dans l'après-midi il a joué au foot avec des copains et y est allé « un peu fort ».

A l'examen clinique, vous sentez un choc de pointe prononcé ainsi qu'une fréquence cardiaque à >220/min. L'ECG montre une tachycardie régulière, à QRS fin. Le patient reste hémodynamiquement stable. Quel traitement donnez-vous?

- A. Midazolam pour sédation et surveillance
- B. Digoxine IV
- C. Amiodarone IV
- D. Adénosine IV
- E. Nifedipine IV

52. Un patient de 35 ans est retrouvé inconscient par la police et amené aux urgences, T 35°C, fréquence respiratoire à 8/min, bradycarde, myosis, hypotendu, somnolent avec des réflexes abolis. Dans ce contexte le premier traitement à administrer:

- A. Benzodiazépines
- B. Flumazenil
- C. Naloxone
- D. Glace fior di latte en iv
- E. Atropine
- F. Physostigmine

53. Un homme de 83 ans se présente aux urgences avec une dyspnée d'apparition brutale. Le scanner que vous faites aux urgences montre (le CT qu'on a eu était plus subtile) :



- A. Un épanchement péricardique
- B. Une embolie pulmonaire
- C. Une tumeur pulmonaire

- D. Une pneumonie
- E. Un épanchement pleural

54. Homme, maladie coronaire et trouble de sommeil, il a des crampes aux mollets. Quel médicament est responsable?

- A. Benzodiazépines
- B. B-bloqueurs
- C. ASS
- D. Diurétiques de l'anse
- E. PPI

55. Patient d'une cinquantaine d'année, fume un demi paquet de clop depuis des années, pas en top forme, BMI élevé, HTA, blabla. Qu'est ce qui améliore le plus sa santé et son risque cardiovasculaire:

- A. Arrêt du tabac
- B. Commencer une statine
- C. Régime sans sel stricte
- D. beta bloquant

56. Une mère venant de mettre au monde son petit garçonnet s'apprête à sortir de la maternité pour retourner à domicile. La mère est inquiète car son premier enfant est décédé 1 an plus tôt d'un syndrome de la mort subite du nourrisson.

Vous êtes pédiatre et vous faites un entretien avant la sortie, que pouvez-vous lui donner comme information.

- ☒ A. l'allaitement et l'abstinence de tabac par l'entourage sont des facteurs protecteurs
- B. la prématurité n'est pas un facteur de risque
- C. le fait d'avoir eu un premier enfant ayant eu une mort subite n'est pas un facteur de risque
- D. le fait de dormir dans le lit parental n'est pas un facteur de risque
- E. la température de la chambre supérieur à 25°C est un facteur protecteur

Réponse A

57. Vous êtes un charmant docteur qui exercez dans un beau cabinet. Un homme (âge moyen voire jeune) vient vous voir pour un gonflement sur l'aine qui s'est développé progressivement ces derniers jours. Vous palpez une hernie qui peut être réductible. Que proposez-vous au patient?

- A. De le référer en urgence à votre collègue chirurgien car il y a un risque d'incarcération.
- B. D'effectuer un CT avec manoeuvre de Valsalva.
- C. D'opérer en électif (toujours chez votre pote chirurgien (celui qui se la pétaït déjà quand il était aux études avec vous)) avec un filet.
- D. D'opérer en électif (toujours chez votre pote) sans mise en place de matériel étranger.

58. Patient de 20 ans qui est hospitalisé en chirurgie viscérale pour une appendicite. Il va être prochainement opéré. On lui perfuse de la co-amoxi et pour les douleurs du paracétamol et de la morphine. Rapidement vous êtes appelé par l'infirmière car le patient

développe un érythème avec une TA de 80/50... (choc anaphylactique.) En plus de lui donner du NaCl 0.9% et des corticostéroïdes. Quel traitement est le plus approprié ?

- A. Cetirizine / Salbutamol
- B. Adrénaline 1mg iv / Cetirizine / Salbutamol
- C. Adrénaline 500 ug im / Cetirizine / Salbutamol
- D. Adrénaline 500 ug sc / Cetirizine / Salbutamol
- E. Homéopathie

Réponse C

59. Une patiente de 26 ans, travaillant dans un sauna, vous consulte pour des tâches blanches présentes dans le dos depuis 6 semaines, autrement asymptomatiques. Vous pensez à un pityriasis versicolor. Quel examen complémentaire faites vous ?

- A. un examen direct dans une solution de potasse 20%
- B. une culture à la recherche d'un dermatophyte
- C. une culture à la recherche d'une levure
- D. une biopsie
- E. pas besoin d'examen complémentaire

60. Un enfant de 8 ans joue au foot avec ses amis et reçoit un coup avec un ballon dans la poitrine. Il s'écroule par terre et nécessite d'une réanimation sur place. Quelle est la cause du besoin de réanimation cardiovasculaire?

- A. Fibrillation ventriculaire
- B. Tamponnade péricardique
- C. Pneumothorax sous tension
- D. Torsade de pointe

61. Homme de 80 ans, retrouvé inconscient dans un appartement locatif avec chauffage au gaz. Les rigidités et les lividités sont fixées. Il n'y a pas de tâche verdâtre sur l'abdomen ni d'emphysème sous-cutané. Qu'est-ce qui peut faire suspecter une intoxication au monoxyde de carbone ?

- A) Couleur rouge clair des lividités
- B) Présence de vomissements à côté et sur le corps
- C) Ecoulement sanguinolent buccal et anal
- D) Odeur de pomme autour du cadavre
- E) Odeur d'amande amer près du dispositif de chauffage

62. Un maçon de 48 ans présente une importante contusion au niveau de la phalange distale de l'index. Il se plaint d'une importante douleur pulsatile. La radiographie ne montre pas de fracture. A l'examen clinique, on observe un hématome sous-unguéal entre l'ongle et le lit de l'ongle.

Que faut-il faire ?

- A. Attendre la résorption de l'hématome
- B. Mettre au repos au moyen d'une attelle plâtrée
- C. Enlever l'ongle et mettre un pansement
- D. Drainer l'hématome par une trépanation de l'ongle
- E.
- F. Enlever l'ongle, désinfecter et remettre l'ongle en place

63. Femme de 30 ans primipare primigeste connue pour une HTA chronique connue depuis 3 ans, vient à la consultation pour un contrôle gynécologique. Elle est au 3ème mois de grossesse et ne présente aucun symptôme. Que proposez-vous?

- A. régime sans sel
- B. Test de la glycosurie
- ☒ C. Mesure de la tension à la maison
- ☒ D. Contrôle échographique rapproché au 3ème trimestre

64. Jeune homme de 26 ans, accident de moto avec choc sur la jambe gauche au niveau antéro-latéral. Il est stable mais se plaint de douleur de plus en plus importante à la jambe. La jambe est chaude, le pouls est palpable. Il a des douleurs importante lors de mouvement actif et passif du pied et des orteils. Diagnostic le plus probable ?

- A. Syndrome compartimental antéro-latéral
- B. Fracture transverse du tibia
- C. Atteinte de l'artère poplitée
- D. Atteinte du nerf interosseux
- E. ...

65. Femme 52 ans, qui vient d'être opérée d'une thyroïdectomie, développe des paresthésies des deux mains, ainsi que des tressaillements des coins des lèvres. Le reste de l'examen clinique est dans la norme (pas de trouble de la perfusion ni de la motricité des mains). Quelle est la cause la plus probable?

- A. Hypocalcémie
- B. Hypercalcémie
- C. Hypokaliémie
- D. Hyperkaliémie

66. Patiente de 24 ans, présentant des arthralgies IPP et métacarpophalangiennes. Depuis quelques temps elle présente une lésion cutanée au niveau du visage et du décolleté. Au laboratoire, on retrouve une anémie, un complément diminué et des anticorps anti-nucléaires positifs. On retrouve du sang et des protéines dans l'urine. Quel est le diagnostic le plus probable?

- A. Wegener
- B. LES
- C. PR
- D.

67. Homme manager de 50 en bsh à part des céphalées fréquentes, se présente avec des douleurs abdominales très intenses. Stable sur le plan circulatoire. Peritonisme dans les 4 quadrants, diffusément douloureux. Que faire:

- A. Laparoscopie exploratrice
- B. Ct abdo
- C. Us abdo
- D. Lavement au nacl

68. Patient d'une trentaine d'année, consommant OH et tabac, qui vient pour des douleurs abdominales, nausées, vomissements, alcoolique. On lui fait une imagerie qui ne démontre

pas de cholélithiase ni de cholécystite. Labo: Amylase élevée, lipase élevée, phosphatase alcaline élevée, γ GT élevée.

Dx le + probable:

- A. Pancréatite alcoolique
- B. Ulcère
- C. Pancréatite biliaire
- D. lithiase en migration dans le cholédoque

69. Patient jeune avec une insuffisance rénale aiguë (créatinine à 1173mmol/l). Quel est la modification qui nécessite une mesure la plus urgente ?

- A. Phosphate à 2.6
- B. Sodium à 131 (135-145)
- C. Potassium à 3.2mmol/L
- D. Élargissement du QRS
- E. pH à 7.24

70. Une femme de 30 ans prend depuis 4 jours 20mg de paroxétine et vient vous voir en urgence. La patiente est sinon en bonne santé. Elle se plaint d'un état anxieux, tremblements, vertiges et nausées.

- A. Virage maniaque
- B. Syndrome sérotoninergique
- C. Akathisie
- D. Dystonie aiguë
- E. Hypotension

71. Une femme enceinte vient et demande comment elle pourrait diminuer les risques de mort subite du nourrisson : vous lui expliquez que les facteurs de risque sont :

- ☒ A. Dormir dans le lit parental
- B. Dormir en position dorsale
- C. la sucette (je pense qu'il voulait dire lolette?)
- D. une température dans le chambre > 21°C

72. Une de vos patientes a subi une IVG il y quelques temps. Il y a 6 mois, elle a déposé plainte pour viol. Le procureur vous appelle pour demander toute la consultation et des rapports médicaux

- A. Je lui file tout ce qu'il veut, même du cash si besoin.
- B. Je l'envoie sur les roses, parce que bon, droit et médecine c'est pas le même monde
- C. Je demande à la secrétaire (ou au secrétaire) d'appeler le médecin cantonal, histoire qu'on s'envoie une petite bière et qu'on discute vite fait de tout ça
- D. J'envoie un audio à la patiente pour la prévenir que le proc veut des infos sur elle
- E. Sur conseil de la commission d'éthique de mon cabinet de généraliste, je demande à l'autorité supérieure (non je parle pas de dieu) à être délié du secret médical.

73. Un étudiant de 22 ans passe son examen oral. Il est très anxieux. A la suite de son examen il ressent une dyspnée, a l'impression qu'il va mourir sous peu. Tachycarde, hypotendue. Il est en BSH. Il a une flexion involontaire des deux poignets. son ECG est normal. Après 1 heure, ses paramètres se stabilisent. Vous faites :

- A. une gazo

- B. Un CT spiralé
- C. rien
- D. D-dimères
- E. Radiographie du thorax

74. Un patient de 60 ans obèse connu pour hypercholestérolémie et HTA qui vient pour des douleurs type brûlure au pied droit. A l'examen hypopallesthésie et hyposensibilité, ulcère au niveau du talon. Hyperkératose sous tout le pied.

Quel examen complémentaire permet de trouver l'étiologie?

- A. CRP
- B. Hba1c
- C. IRM du pied
- D. Rx du pied

75. Une femme de 27 ans présente depuis 24h des douleurs en coup de poignard en fosse iliaque droite accompagnées d'un écoulement vaginal brun. Les urines et les selles sont sans particularité. Son cycle est habituellement régulier (30 jours). Dernières règles il y a 7 semaines. Elle a plusieurs partenaires avec lesquelles elle a des rapports non protégés.

Quel est l'examen complémentaire le plus utile/pertinent ?

- A. US rénal
- B. Laboratoire hépatique et rénal
- ☒ C. Dosage urinaire de β -hcG
- D. Paramètres inflammatoires
- E. CT abdominal

Réponse C

76. Diabétique de 45 ans, tuméfaction du scrotum droit rapidement augmentant en taille. Il a des douleurs et de la fièvre à 39.5°C. Au labo: leucocytose, CRP élevé, thrombocytes et INR dans les normes.

Quoi faire pour sauver la vie de ce Monsieur?

- A. Immunothérapie
- B. Chimiothérapie
- C. Chirurgie
- D. Oxygénothérapie hyperbar

77. K' Patient de 40 ans sans pathologie connue qui doit subir une injection de produit de contraste pour un examen radiologique. Quelle(s) complication(s) est(sont) possible(s) ?

- A. choc anaphylactique
- B. urticaire
- C. bronchospasme
- D. oedème de Quincke

78. Patient de 63 ans, douleurs thoraciques respirodépendantes, dyspnée en augmentation, radio avec léger épaississement de la

plèvre et petit épanchement. Dx le plus probable :

- A. Mésothéliome
- B. Bronchiocarcinome
- C. Tuberculose

- D. Adénocarcinome
- E. Thymome

79. Travailleur en bâtiment qui consulte car a reçu une poutrelle sur l'hémiface gauche. Il présente une lacération du sourcil et tuméfaction de l'orbite gauche. A l'examen clinique, il y a une limitation à l'élévation en abduction et adduction, avec une légère limitation à l'abaissement également.

- A. Blocage mécanique des muscles
- B. Paralysie du nerf oculomoteur
- C. Parésie du muscle supérieur droit
- D. Parésie du muscle inférieur droit
- E. Parésie partielle du nerf oculomoteur

Réponse: A

80. Femme de 59 ans, consulte pour des palpitations et vertige. Elle a subi une thyroïdectomie il y a 12 ans et elle est sous L-thyroxine en prévention contre une récurrence. Un ECG montre une tachycardie sinusale à 112 bpm. Il y a 6 mois son ECG montrait un rythme sinusal avec fréquence dans la norme.

Que faites-vous?

- A. Un autre ECG dans 1 semaine
- B. Mesurer la TSH, T3 libre et T4
- C. Donner un bêta bloquant
- D. Donner un anxiolytique

81. Lors de l'administration de produit de contraste intraveineux, vous pouvez vous attendre à la/les réaction/s suivante/s:

- A. un choc anaphylactique
- B. un bronchospasme
- C. un oedème de Quincke
- D. un urticaire

82. Une femme de 19 ans, nulligeste, vient au cabinet pour une contraception par stérilet. Quelles informations devez-vous lui donner concernant la contraception par stérilet :

- A. L'efficacité du stérilet est de 90%.
- B. Le stérilet n'est pas un moyen de contraception adapté pour une nulligeste.
- C. Avec un stérilet, il y a un risque de diminution de la fertilité.
- D. Avec un stérilet, le risque d'infection est triplé.
- E. Il faut faire un contrôle 1-2 mois après la pose en raison d'un faible risque d'expulsion.

83. Femme de 21 ans vient pour des écoulements vaginaux verdâtre et nauséabonds en augmentation. On effectue un prélèvement, que faire:

- A. Etaler sur une lame et attendre 5 min
- B. Etaler sur une lame avec du potasse 30%

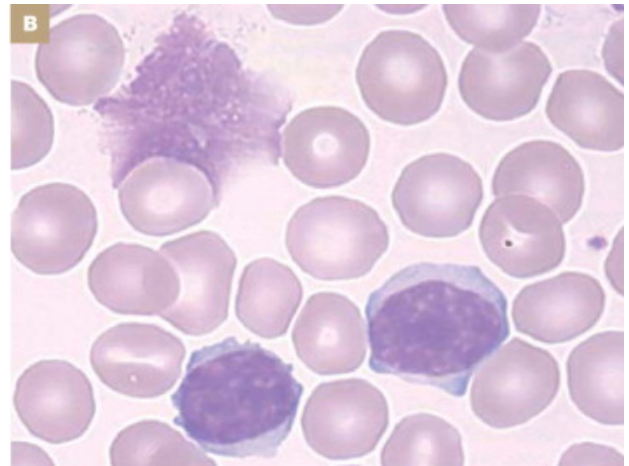
- C. Etaler sur une lame avec du NaCl 0.9%
 - D. Faire une fixation sur lame
- Réponse : C

84. Patiente de 60 ans, avec symptômes B et adénopathies. Le frotti sanguin montre cette image:

Quel est le diagnostic le plus probable?

- A. Leucémie myéloïde chronique
- B. Leucémie lymphoïde chronique
- C. lymphome non hodgkinien
- D. leucémie lymphocytaire aigue

Réponse: B



85. Un patient a fait une chute il y a une semaine, il vous consulte car il dit avoir toujours mal au poignet. Une radiographie de face et profile est réalisée. De quoi s'agit-il?

- A. Fracture du scaphoïde
- B. fracture de Galeazzi
- C. Entorse sévère du poignet
- D. Fracture en extension (Pouteau-Colles)



86. Au sujet de l'assurance maladie de base en Suisse. Quelle affirmation est fausse?

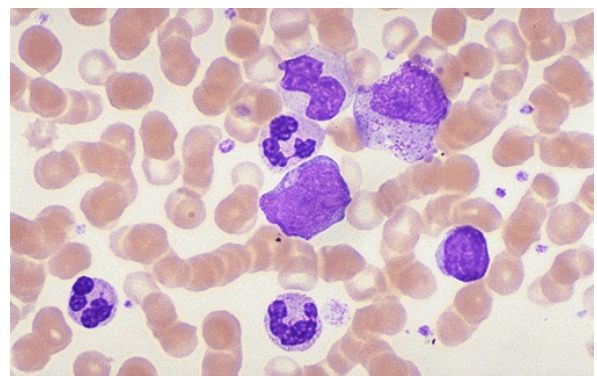
- A. Elle prend en charge tous les frais liés à la grossesse
- B. Elle prend en charge l'ensemble des soins aux personnes âgées
- C. Elle protège contre les conséquences économiques d'une maladie
- D. Elle respecte le principe de solidarité entre les personnes malades et non malades

87. Une petite fille de 4 ans atteinte de mucoviscidose et amenée par sa mère qui remarque que sa fille tousse souvent, notamment le matin. A l'auscultation la patiente est encombrée. On réalise un frotti de gorge, que va-t-on retrouver à ce frotti?

- A. P. aeruginosa
- B. C. burnetti
- C. Mycoplasma
- D. Flore non spécifique

88. On réalise un frotti sanguin (cf. ci-contre) chez un patient âgé se plaignant de fatigue et présentant une leucocytose à 70G/L, une anémie et une thrombocytopénie. Quelle mutation est associée à cette pathologie?

- A. NF-1



- B. EGFR
- C. BCR-ABL
- D. HER-2
- E. K-RAS

89. Un enfant de 2 ans se présente avec sa mère chez le pédiatre. Elle raconte qu'en comparaison avec ses 2 grandes sœurs, son développement est retardé. Même s'il mange très peu, il a un abdomen protubérant. Les selles sont toujours visqueuses. Les 5 premiers mois, sa mère l'a allaité sans problème. Le garçon est en taille et en poids inférieur au P3, il est pâle, pleurnichard et a un abdomen large. Que faites-vous ?

- A. Sonographie hépatique
- B. Anticorps contre la transglutaminase
- C. Mesure des paramètres rénaux
- D. Analyser les selles à la recherche de parasites et vers
- E. CT de l'abdomen

90. Vous vous occupez d'un bébé né prématurément à 28ème. Ses parents vous apprennent que ça grande soeur est décédée d'une mort subite du nourrisson il y a 6 ans. Ils sont très inquiets et vous demandent des renseignements au sujet de la Mort subite du nourrisson. Parmi ces déclarations, laquelle est correcte ?

- A. une mort subite du nourrisson dans la fratrie n'est pas un facteur de risque
- B. les risques de mort subite du nourrisson sont détectables à l'EEG
- C. faire dormir le bébé sur le ventre est un facteur protecteur
- D. la prématurité n'est pas un facteur de risque de mort subite du nourrisson
- E. allaiter et éviter de fumer en présence de l'enfant sont des facteurs protecteur**

91. Homme de 30 ans, diarrhées depuis 3 semaines. Pas d'état fébrile ni d'ictère, il a une hématochézie et une douleur en fosse iliaque droite. Légère défense sans détente, bruits abdominaux normaux. Quel est le diagnostic le plus probable?

- A. Maladie de Whipple
- B. Cancer du pancréas
- C. Maladie de Crohn
- D. Appendicite
- E. Cholecystite

92. Vous êtes médecin installé en ville et vous recevez un courrier d'un procureur qui demande des renseignements concernant une de vos patientes. Il s'agit d'une femme de 22 ans, ancienne toxicomane que vous avez examiné il y a 6 mois pour une agression sexuelle présumée. Selon ses explications, elle a passé une soirée dans une boîte de nuit et elle s'est réveillée chez elle en ayant aucun souvenir de la soirée. Cette patiente a fait une interruption volontaire de grossesse 3 mois plus tôt. Le procureur demande le rapport de la consultation fait après la soirée en question et désire connaître tous les antécédents, ainsi que la médication de la patiente. Quelle est l'attitude la plus correcte d'un point de vue médico-légal ?

- A. Vous envoyez le rapport demandé au procureur dans les meilleurs délais.
- B. Vous contactez votre patiente pour l'informer de la demande.

- C. Vous annoncez à l'autorité compétente la toxicomanie de votre patiente.
- D. Vous contactez le médecin cantonal, pour annoncer l'interruption de la grossesse.
- E. Vous demandez à l'autorité compétente d'être libéré du secret médical.

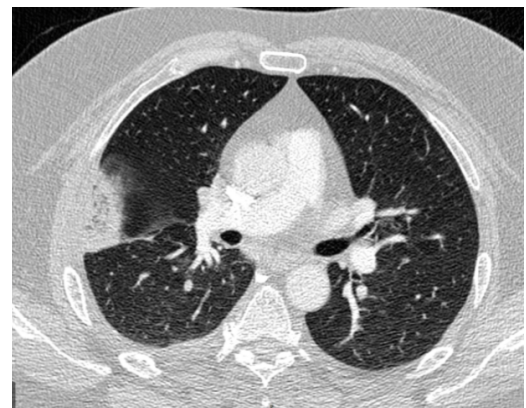
93. Patiente obèse, qui a subi une opération du fémur après un accident de voiture. 3 jours après apparaît une dyspnée aiguë et des douleurs thoraciques et décède subitement. Antécédents sont un cancer mammaire T1N0M0 sous rémission. Quelle est l'étiologie du décès ?



- A. Embolie pulmonaire
- B. Métastases pulmonaires
- C. Cancer pulmonaire
- D. Pneumopathie interstitielle

94. Femme de 68 ans qui revient de Thaïlande, elle est sous Tamoxifène suite à un cancer du sein traité il y a 2 ans par tumorectomie/RT. Elle est envoyée par son médecin traitant pour dyspnée en péjoration, associée à de la toux et des crachats sanguinolents. T 38.8, Sat 96, TA 135/80, FC 80, FR 22. Les D-dimères sont à 2200. On nous donne une coupe de CT. Quelle est la cause de l'épanchement parenchymateux que l'on voit sur le CT ?

- A. Tumeur
- B. Atélectasie
- C. Infarctus pulmonaire
- D. Pneumonie
- E. Épanchement intra scissural



(l'EP n'était pas dans les réponses, c'est pas un oubli...!)

95. Un jeune homme a eu un accident de moto, où il est tombé sur le côté gauche et plus particulièrement sur la jambe gauche. A l'arrivée à l'hôpital accompagné des secours, il se plaint uniquement d'une très forte douleur à la jambe gauche. A l'examen physique, la jambe et le pied gauches sont rouges et chauds, pouls palpables. Une très forte douleur est ressentie à la mobilisation active et passive des orteils. Que suspectez-vous ?

- A. Syndrome des loges antero-latéral de la jambe gauche
- B. Fracture du plateau tibial
- C. Rupture d'un kyste poplité
- D. Déchirure du nerf ...

Deuxième round, 8K'

96. Un patient de 33 ans subit une fracture fermée de la jambe lors d'un match de football. Il présente un syndrome des loges. Dans quel ordre les symptômes apparaissent-ils ?

- A. Perte de sensibilité, douleurs, atteinte de la motricité, disparition du poul distal.
- B. Perte de sensibilité, atteinte de la motricité, disparition du poul distal, douleurs.
- C. Douleurs, perte de sensibilité, disparition du poul distal, atteinte de la motricité.
- D. Douleurs, perte de sensibilité, atteinte de la motricité, disparition du poul distal.
- E. Douleurs, atteinte de la motricité, disparition du poul distal, perte de sensibilité.

97. Enfant de 4 mois qui se présente avec des convulsions et hémiparesie droite. Afébrile, anamnèse familiale négative pour des convulsions. Grossesse et accouchement s
Aux Rx, pas de fracture du crâne ou des membres mais hémorragies en rétiniennes en flamèche DDC et le CT montre une hémorragie sous durale. Quel est le Dx le plus probable?

- A. Syndrome enfant battu
- B. Rupture d'une malformation artérioveineuse
- C. Hémorragie sur HTA
- D. C'est la mer noire

98. Un patient de 23 ans vient à votre consultation car depuis plusieurs jours il a mal à sa paupière inférieure gauche. Lésion érythémateuse sous les cils à 2mm du bord externe de l'oeil. Vision 10/10 bilatéral (pas d'image). Lorsqu'on essaie de toucher la paupière inférieure le patient se plaint qu'on lui fait mal. Quel est le dg le plus probable?

- A. chalazion
- B. orgelet
- C. dacryadénite
- D. dacryocystite

99. Un homme de 56 ans, connu pour un carcinome non à petit cellule d'emblée métastatique (foie et surrénale), ayant eu deux cycles de gemcitabine sans effet, vous consulte pour des douleurs dans le dos nouvelle. Ses douleurs sont paravertébrale gauche, irradient dans la jambe gauche. Elles sont associées à une paresthésie et une faiblesse dans la jambe gauche, une anesthésie para-anale et une rétention urinaire nouvelle. Ses douleurs sont également reproduites à la percussion vertébrale.

Quelle pathologie a-t-il le plus de chance de présenter?

- A. Syndrome paranéoplasique
- B. Sclérose latérale amyotrophique
- C. Syndrom de la queue de cheval
- D. Polyneuropathie
- E. Myélite transverse

100. Un maçon de 48 ans présente une importante contusion au niveau de la phalange distale de l'index. Il se plaint d'une importante douleur pulsatile. La radiographie ne montre pas de fracture. A l'examen clinique, on observe un hématome sous-unguéal entre l'ongle et le lit de l'ongle.

Que faut-il faire ?

- A. Attendre la résorption de l'hématome
- B. Mettre au repos au moyen d'une attelle plâtrée
- C. Enlever l'ongle et mettre un pansement
- D. Drainer l'hématome par une trépanation de l'ongle
- E. Enlever l'ongle, désinfecter et remettre l'ongle en place

101. Une femme de 80 ans fait un AVP. elle a suite à cette accident une fracture de l'humérus. Au status, on constate que l'extension des doigts et du poignet est impossible cependant la patient arrive à les fléchir et à écarter les doigts. Quel nerf est touché?

- A. médian
- B. radial
- C. ulnaire
- D. axillaire
- E. musculo cutane

102. Un patient avec une constipation chronique et des douleurs à la défécation. après plusieurs investigations, on détecte une masse 2cm au niveau de la marge anale avec plus au haut un obstacle infranchissable.

on diagnostique une adénocarcinome anale. il y a des métastases loco-régionales mais pas de métastase à distance.

Quelle est la prise en charge?

- A. chimio systémique définitive
- B. radiothérapie plus hormonothérapie
- C. radio chimio neo adjuvante
- D. chirurgie en primaire
- E. radiothérapie

103. Un patient de 30 ans vient à votre cabinet pour des diarrhées depuis 3 mois. Il rapporte aussi des hématochézie et une douleur en fosse iliaque droite. Son état général est conservé, il n'a notamment pas de fièvre et pas d'ictère. Au status, l'abdomen est souple avec une sensibilité en fosse iliaque droite et rien d'autre de notable. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. appendicite
- B. cholécystite
- C. maladie de Crohn
- D. maladie de Whipple
- E. cancer du pancréas

104. Un homme de 55 ans, SDF, en mauvais état, amené par l'ambulance. Il est agité et répond à côté de la plaque lors de l'examen clinique. Il sent l'alcool. Que faites-vous en priorité?

- A. Thiamine
- B. Glucose

- C. Diazepam
- D. ...

105. Homme, 26 ans, check up IST, a des rapports sexuels avec des femmes et hommes, anal et vaginal. Hépatite, HIV etc. négatif. TPPA positif, FTA positif, IgM négatif, VDRL positif. Qu'est-ce qu'est correct?

- A. Doxycycline
- B. il ne faut pas traiter les partenaires
- C. contrôle sanguin dans 3 mois
- D. Penicilline i.m. 3x sur 7 jours
- E. Benzathin penicilline I.m 1x

106. Patient de 82 ans qui se plaint de faiblesses musculaires, n'arrive presque plus à marcher, et douleurs musculaires. Prend plein de traitements, lequel est susceptible de causer ces symptômes?

- A. aspirine
- B. lisinopril
- C. atorvastatine
- D. allopurinol
- E. bisoprolol

107. Un patient de 32 ans en bonne santé habituelle se présente aux urgences avec de la fièvre, des céphalées et des douleurs musculaires. Vous trouvez à l'examen clinique les lésions suivantes. Quelle mesure diagnostique est la plus pertinente ?

- A. Une ponction lombaire
- B. Un frottis cutané
- C. Un avis dermatologique
- D. Une angiographie
- E. (Je sais plus le 5eme)



108. Patiente de 68 ans qui consulte chez son médecin-traitant en raison de coxalgies droites apparues progressivement depuis 1 an. Les douleurs sont aggravées lors de la charge. Récemment, elle a chuté de sa hauteur avec réception du côté droite. Depuis cet événement, les douleurs sont plus intenses et elle doit marcher avec une canne. Son périmètre de marche est limité à 15 minutes. Lors de l'examen clinique, sa hanche droite est limitée en flexion à 90°, en



rotation interne à 0° et en rotation externe à 10°. Elle présente une boiterie importante lors de la marche. Son généraliste lui fait une radiographie qui montre quelque-chose comme celle-ci. Quel est le diagnostic ?

- A. Luxation de la hanche droite
- B. Coxarthrose droite
- C. Fracture du col du fémur droite
- D. Fracture pertrochantérienne droite

109. Patiente de 46 ans qui se présente avec un nodule au sein droit. Vous palpez un nodule de 1.3cm mal délimité au niveau du quadrant supéro-intérieur du sein. Pas d'adénopathie palpée. L'imagerie confirme la découverte clinique. La biopsie met en évidence un carcinome canalaire invasif de grade 3, avec récepteurs aux oestrogènes et progestérone positifs, Her2 négatif. Quel est le traitement approprié ?

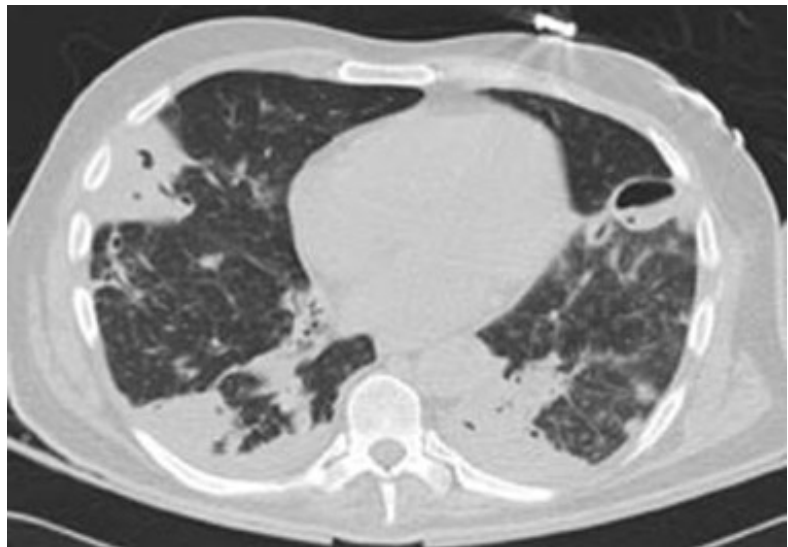
- A. Tumorectomie
- B. Quadrantectomie
- C. Tumorectomie + ganglion sentinelle
- D. Mastectomie + ganglion sentinelle
- E. Mastectomie + curage ganglionnaire

110. Une jeune fille de 24 ans vient vous voir pour pollakiurie, polliurie. Elle n'a pas fait de fièvre, ni de douleurs. Elle revient de vacances de 3 semaines avec son nouvel amoureux. Que devez vous faire en premier ?

- A. culture des urines
- B. bandelette urinaire
- C. test de grossesse
- D. US reins

111. Un patient 80 ans, avec insuffisance cardiaque est fébrile depuis peu, et a une toux productive. On fait un CT. Quel est le diagnostic ?

- A. Embolie pulmonaire
- B. Pneumonie abcédante
- C. Carcinome bronchique périphérique
- D. Tuberculose



112. Un homme de 58 ans vient à votre cabinet après être tombé à ski. Il ne peut pas activement faire d'abduction ni de flexion du membre supérieur. A l'examen clinique, vous notez : pas de déformation de l'épaule, mobilisation passive libre, douleur dans les mouvements surtout de rotation extrême. Quelle est la lésion la plus probable ?

- A. Contusion de l'épaule
- B. Luxation coraco-acromiale
- C. Lésion du long chef du biceps
- D. Luxation gléno-humérale
- E. Lésion complète de la coiffe des rotateurs

113. Une choupette de 4 ans née à terme sans complication est amenée par sa mère, car celle-ci trouve que sa fille ne prend pas assez de poids depuis l'introduction d'une alimentation variée. Malgré une alimentation correcte et diversifiée et l'absence de troubles digestifs elle mesure 90cm ($p<3$), pèse 12kg ($p<3$) et a un périmètre crânien de 50cm ($p=50$). En cherchant dans son dossier médical vous remarquez que la courbe de croissance était au percentil 50 jusqu'à l'âge de 2ans et que c'est à ce moment que la courbe s'est cassée. Une radiographie de la main montre un retard d'âge osseux. Quel est le diagnostic le plus probable?

- A. Malnutrition
- B. Malabsorption
- C. Anomalie chromosomique
- D. Déficit en GH
- E. Retard de croissance constitutionnel

Réponse correcte: D

114. Patiente de 66 ans qui va recevoir 2 culots érythrocytaires pour une anémie symptomatique. 5 minutes après le début de la perfusion du 1^e CE, elle se sent mal et développe une hypotension à 80/50 et des douleurs violentes dans le dos et les flancs. Quelle est l'attitude la plus urgente ?

- A. Donner des corticostéroïdes
- B. Donner des anti-histaminiques
- C. Donner le 2^e CE
- D. Arrêt de la transfusion du CE en cours
- E. Adrénaline

115. Patient de 64 ans, avec de la toux persistante depuis 6 semaines et des expectorations jaunâtres avec parfois du sang et une dyspnée en augmentation à l'effort. Patient rapporte une perte pondérale de 3 kg (non voulue) en 1 mois. il est connu pour 60 UPA. A l'examen clinique : pas de fièvre, diminution des bruits respiratoires à gauche.

La consultation chez l'ORL n'a rien donné

- A. Ca Bronchique
- B. Pneumopathie interstitielle
- C. Pneumothorax spontané
- D. Bronchectasie
- E. Pneumonie à pneumocoques

116. Fille de 5ans avec douleur au genou droit. Genou chaud, rouge, douloureux à la palpation. Parmi diagnostics différentiels suivants, quelle pathologie doit être traitée en urgence?

- A. Arthrite septique
- B. Polyarthrite juvénile
- C. Arthrite psoriasique
- D. Arthrite de lyme
- E. ...

117. Jeune fille de 4 ans, a des douleurs à la jambe depuis 3 semaines qui la réveillent la nuit. Qu'est ce qui ne rentre pas dans le diagnostic différentiel ?

- A. Douleurs de croissance
- B. Ostéomyélite
- C. Arthrite juvénile idiopathique
- D. Ostéome ostéoïde
- E. Leucémie aiguë

118. Jeune homme de 15 ans qui consulte pour des douleurs au genou droit qui apparaissent à la charge. On fait une radiographie du genou (*à l'examen il n'y a pas la flèche bien entendu ;)*). Quel est le diagnostic?

- A. Maladie de Paget
- B. Ostéochondrite dissecante
- C. Lésion du ménisque interne
- D. Rx normale



119. Patiente de 60 ans, consulte pour des vomissements depuis la veille. Depuis 1 semaine elle présente une asthénie, des myalgies et des céphalées ainsi qu'un état fébrile. Son médecin traitant lui a prescrit pour cela, 1g 4x/j de dafalgan ainsi que 400mg 4x/j, elle a pris en plus de cela des médicaments anti-grippe de sa propre pharmacie une fois par jour. A l'examen clinique elle a des constantes dans la norme, afebrile, présente des douleurs diffuses à la palpation abdominale. Au labo, ASAT/ALAT/gammaGT augmenté, bilirubine dans la norme. Quel est le diagnostic ?

- A. Intoxication à ibuprofène
- B. Intoxication au paracétamol
- C. Mononucléose
- D. Grippe
- E. Gastro-entérite

120. Patient de 40 ans, vient pour des lésions cutanées qui sont apparues il y a plusieurs semaines. Elles se trouvent sur les bras, le tronc, les jambes et dans la bouche. Elles sont de couleur violette. Il est fatigué depuis plusieurs mois. Il présente également des adénopathies. Quel aspect de l'anamnèse est le plus important à évoquer ?

- A. anamnèse atopique
- B. anamnèse sexuelle
- C. anamnèse voyage
- D. anamnèse médicamenteuse



121. Femme de 72 ans, jusqu'ici en bonne santé, qui présente une irrégularité de transit depuis 6 mois. Elle consulte son médecin traitant ce jour après avoir constaté la présence de sang dans ses selles. Quelle est la prochaine étape diagnostique ?

- A. Colonoscopie
- B. Toucher rectal
- C. CT scan abdo
- D. FSC

E. Dosage du PSA

122. Femme de 53 ans, connue pour une sclérose en plaque et sous traitement d'Interféron. Elle consulte, accompagnée par son conjoint à cause d'un hémisyndrome droit apparu ce matin. Le conjoint raconte qu'elle souffrait de poussées de fièvre ces dernières semaines. Examen clinique: Au test des bras tendus le bras droit s'abaisse, auscultation cardiaque souffle systolique 3/6, jamais mis en évidence auparavant, avec un maximum au 5e espace intercostal à droit. (Et beaucoup plus d'infos...) Quelle est l'étiologie ?

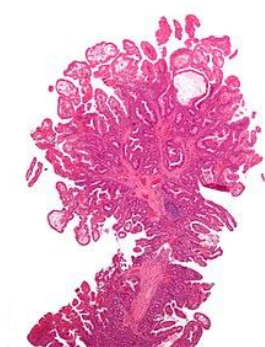
- A. Endocardite
- B. Effet indésirable de la thérapie de l'interféron
- C. Poussée de sclérose en plaque
- D. ...

123 K' Une patiente de 75 ans se plaint de douleurs diffuses abdominales. Elle se plaint de nausées et a vomi. Elle a subi une résection iléale il y a 3 jours et n'a toujours pas émis de selles depuis. Elle a reçu une antalgie de morphine qui l'a soulage bien. A l'examen on retrouve un abdomen distendu non sensible à la palpation, sans défense ni détente. Les bruits auscultés sont de tonalité métalloïdes.

Quelle/s mesure/s doivent être prises pour cette patiente?

- A. Pose de sonde nasogastrique
- B. Augmentation des doses de morphine
- C. Administration d'antiémétiques
- D. ...

124. Type A. Homme de 72 ans. On trouve lors d'une coloscopie de nombreux polypes, qui sont trop grand pour une résection endoscopique. On procède alors à une résection du sigmoïde. On nous donne une coupe de la patho.



Quel élément influence le plus la suite du traitement ?

- A. le degré d'invasion de la paroi
- B. Le degré de dysplasie
- C. La taille du polype
- D. présence de mutation KRAS

125. A Un patient a des palpitations et il y a deux ECG à l'examen : le premier est actuel et montre une tachycardie supra-ventriculaire (QRS fin, on voit pas vraiment d'onde P) et le patient vous dit que son cardiologue lui a dit de toujours avoir sur lui un ECG qu'il vous montre. Cet ECG montre une pré-activation de QRS (syndrome de WPW).

La réponse était une tachycardie supraventriculaire sur faisceau accessoire.

126. Vous êtes généraliste et la femme d'un patient de 72 ans vous appelle car son mari a fait un malaise il y a une vingtaine de minutes. Il a perdu connaissance pendant une dizaine de minutes et s'est réveillé ensuite. Il a eu besoin d'aide pour se lever en raison de vertiges

très importants. Il a ensuite parlé de manière incohérente quelques minutes mais va beaucoup mieux maintenant, à l'exception d'une difficulté à bouger le bras gauche. Quelle est l'attitude à tenir ?

- A. Vous ne faites rien, le malaise est terminé de toute façon.
- B. Il doit venir au cabinet pour être examiné dans la journée.
- C. Vous vous rendez immédiatement chez le patient pour prendre les mesures nécessaires.
- D. Le patient doit être immédiatement hospitalisé dans une unité cérébro-vasculaire.
- E. Vous demandez à l'épouse de vous rappeler dans 2h pour vous donner des nouvelles.

127. Un serrurier de 62 ans consulte son médecin traitant pour des douleurs de son genou gauche depuis 5 semaines. Il doit souvent porter de lourdes charges à son travail. Il ne se souvient pas d'avoir eu un trauma au niveau de son genou et fait souvent du volley au club de gymnastique local. Une IRM montre une atteinte dégénérative du ménisque médial. Laquelle de ces assurances prendra en charge les frais d'éventuels traitement ?

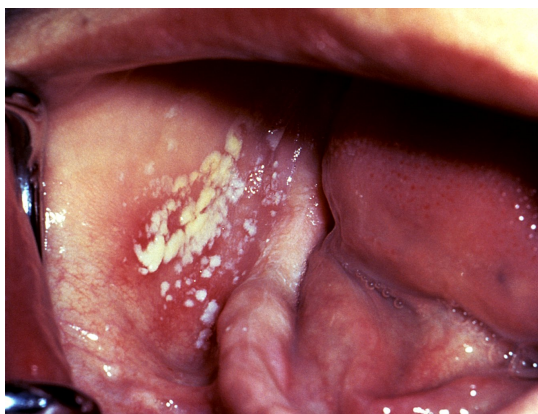
- A. Loi sur l'assurance maladie obligatoire (LAMal)
- B. Loi sur l'assurance accident professionnelle
- C. Loi sur l'assurance accident non professionnel
- D. Me souvient plus mais une assurance trop chelou
- E. Me souvient plus mais une assurance encore plus chelou

128. Un patient de 78 ans connu pour une démence est hospitalisé dans votre service (je ne sais plus la raison). L'infirmière vous appelle pendant la nuit car il présente un état confusionnel. Vous posez une sonde urinaire. Le lendemain le patient présente une hématurie macroscopique. Quelle est la cause la plus probable de cette hématurie ?

- A. Urétrite aiguë
- B. Rupture du ballonnet de la sonde
- C. Mauvais positionnement de la sonde
- D. Hémospermie sur prostatite
- E. ...

129. Patient de 30 ans qui a des lésions dans la bouche (cf image), il a déjà eu une semaine de traitement anti-mycosique locale, qui a été pris correctement, mais certaines lésions sont toujours présentes (dans le sillon gengivo-dentaire, côté interne de la joue), que faire :

1. Prescrire encore une semaine de traitement anti-mycosique locale
2. L'envoyer chez le chirurgien maxilo-faciale
3. Prescrire un anti-septique (soin de bouche)
4. ...



130 Patiente de 28 ans se présente aux urgences pour des douleurs en fosse iliaque droite et de la fièvre. Ces douleurs augmentent progressivement et sont accompagnées de nausée. Elle est enceinte de 28 SA. Vous suspectez une appendicite. Une échographie est effectuée par un radiologue mais n'est pas concluante.

Vous effectuez ensuite:

- A- Une radiographie de l'abdomen sans préparation
- B- Une IRM abdominale avec produit de contraste
- ☒ C- Une IRM abdominale sans produit de contraste
- D- Un scanner abdominal avec produit de contraste
- E- Un scanner abdominal sans produit de contraste

131 Patient de 20 ans, fait de la fièvre lors de son service militaire avec baisse de l'état général. Suspicion de méningite, il est amené à l'hôpital.

A son arrivée le patient est fébrile à 39°, GCS à 11, tachycarde, tachypnéique, hypotendu, raideur de nuque et une parésie du bras gauche (probablement nouvelle)

Dans quel ordre faire:

- A. Hémoc- AB- CT-PL
- B. PL-Hémoc- AB- CT
- C. AB-Hémoc-CT-PL
- D. PL-CT-Hémoc- AB

132 Boucher de 57 ans se coupe deux jours plus tôt l'avant-bras sur 6 cm. Il se soigne seul mais se présente aujourd'hui avec une plaie béante, écoulement et signes inflammatoires locaux. Patient en bon état général, pas de fièvre

Attitude:

- A. Débridement étendu et fermeture secondaire
- B. Rincer abondamment et suturer
- C. Rincer abondamment et AB systémique

133. Un jeune homme de 32 ans se présente à votre cabinet pour des épistaxis à répétitions. A l'examen clinique vous remarquez que le septum nasal est transpercé. Quelle en est la cause la plus probable?

- A. Prise à répétition de cocaïne en sniff
- B. Malformation du plexus de Kiesselbach
- C. ...